

03/10/2024

Le stress et les maladies psychosomatiques

Dr. sahnoun .N

I/ Introduction

Lorsqu'un individu est soumis à une agression ou une menace quelle qu'elle soit, il y répond par une réaction que l'on nomme « stress ».

Cette réponse de l'organisme en situation difficile est donc naturelle, normale et utile à la survie. Elle le met en alerte et libère les moyens énergétiques qui lui permettent de contrer l'agent stressant.

Cet ensemble de réactions d'adaptation est appelé stress protecteur ou bien encore stress adaptatif.

Un même événement déclenchant a des répercussions différentes chez des individus, en fonction de leur âge, de leur personnalité et de leur environnement psychosocial.

II/ Définitions

- ✓ Le terme **stress** est un mot anglais, dérivant du latin « stringere », serré, qui évoque une situation de pression et de contrainte.

Le stress est un processus complexe comprenant la réponse physiologique, biologique et psychologique de l'individu soumis à une agression, une menace, une contrainte physique ou psychique, une situation imprévue traumatisante.

En 1936, Hans Selye le définissait comme une « réponse non spécifique, variable d'un individu à l'autre, à une agression physique, agression responsable d'une réaction hormonale et neurovégétative à l'origine d'un véritable syndrome général d'adaptation »

- ✓ Psychosomatique = du grec ancien : psyché, l'esprit et soma, le corps) dont la paternité revient à un psychiatre allemand Heinroth (1773-1843). Le terme psychosomatique désigne des troubles occasionnés ou aggravés par des facteurs psychiques, la somatisation. Il concerne l'ensemble des effets de l'esprit sur le corps humain. Le corps et la psyché sont intimement liés : l'un ne peut vivre sans l'autre et ils sont en constante interaction

- La psychosomatique peut être définie comme l'étude des processus psychiques entrant en jeu dans les désorganisations somatiques.
- On parle de maladie psychosomatique si :
 - Il existe des altérations organiques ou biologiques objectivables
 - Ces altérations tirent une partie de leur origine du psychisme
- Une fois installé, le trouble physique évolue pour son propre compte, indépendamment des facteurs psychologiques qui ont été à son origine.

III/ La réaction de stress normal

La réaction de stress normal se déroule en plusieurs phases :

- **Une phase d'alarme** : des moyens de défense sont mobilisés pour réagir rapidement à l'agent stressant. Le stress cause l'apparition de réactions physiques et psychologiques accélération du rythme cardiaque et respiratoire, contraction musculaire augmentation de la vigilance avec un sentiment de détresse ou d'oppression.
- **Une phase de résistance** : lorsque l'agent stressant persiste, la défense est maintenue et les réserves d'énergie nécessaires sont reconstituées. Les premiers signes physiques de la réaction d'alarme ont disparu. Le corps s'adapte et la résistance s'élève au-dessus de la normale.
- **Une phase d'épuisement** : lorsque l'exposition au stress se poursuit trop longtemps, les défenses s'effondrent. La personne n'est plus capable de répondre adéquatement à la situation stressante et des symptômes caractéristiques apparaissent (dépression, anxiété).
- **Une phase de récupération** : lorsque l'agent stressant est géré, la tension baisse, la -, les réserves énergétiques se reconstituent.

VI/ Biologie de l'adaptation au stress

Le maintien de l'homéostasie de l'organisme vivant est assuré, chez les mammifères, par quatre grands systèmes de communication : système nerveux central (SNC), le système nerveux autonome (SNA), le système endocrinien et le système immunitaire.

Ces quatre systèmes communiquent entre eux grâce à la production de médiateurs communs (hormones, cytokines, neuromédiateurs, neuropeptides).

Du fait de cette communauté des voies, et des médiateurs utilisés, des stress de nature différente (physique, psychologique, infectieuse ou toxique) peuvent avoir des effets convergents.

- **Les facteurs de stress physiques (douleur, froid, bruit, espace, etc.)** : transmettent des signaux nerveux par l'intermédiaire de fibres sensibles vers les neurones adrénergiques, noradrénergiques et sérotoninergiques ; conduisant à la libération de la *corticotropin releasing hormone* (CRH), ainsi que de la vasopressine, ou hormone antidiurétique, qui augmente la pression artérielle. La CRH, est à l'origine **de l'activation de l'axe du stress**.

Les infections et inflammations : provoquent la libération de cytokines inflammatoires qui vont stimuler les cellules de la barrière hémato encéphalique, qui aboutit à **l'activation de l'axe de stress**.

- **Système neuroendocrinien** : La CRH entraîne une augmentation de la pression sanguine, tachycardie, une réduction de l'activité gastro-intestinale, et, au niveau comportemental et affectif : réaction dépressive, réduction de l'interaction sociale, de l'appétit, de la réceptivité sexuelle.
- **Systèmes sympathique et parasympathique** : Le rôle du SNA concerne les muscles lisses, le cœur et les vaisseaux, les poumons et le système digestif, mais aussi les glandes endocrines. Le système sympathique est mis en jeu dans des situations d'urgences ou d'émotions fortes, comme la peur ou la colère, mais également au niveau des organes lors des épisodes

- de souffrance tissulaire. En revanche, le système parasympathique est actif au repos et lors des phases de récupération.
- **Système immunitaire** : L'exposition aiguë à une situation difficile a des conséquences sur l'immunité. Chez des étudiants en première année de médecine, des chercheurs américains ont montré une diminution de la production d'interféron leucocytaire, ainsi que du pourcentage de cellules tueuses naturelles et de leur activité cytotoxique, au cours de la période des examens.

Système nerveux central : Le thalamus intervient dans les réponses courtes, l'amygdale et le système limbique, dans les réponses émotionnelles, l'hippocampe pour la mémoire et le cortex pour l'interprétation des éléments du stress.

IV/ Stress positif et stress négatif

- L'homme a besoin dans sa vie quotidienne d'un niveau minimal de stress. Des objectifs accessibles, des échéances réalistes, ajustés au plan de vie, aux valeurs, aux circonstances et aux capacités personnelles. Le stress est en ce cas positif, il mobilise les ressources. C'est ce que l'on appelle l'eustress.
- Les situations ressenties comme menaçantes, contraignantes ou déplaisantes, l'impression de ne pas disposer des ressources nécessaires pour y répondre, de nombreuses demandes émanant simultanément de l'environnement ou durant une trop longue période conduisent à la détresse. Ce stress négatif induit une diminution des performances et mène à l'épuisement. C'est ce que l'on appelle le distress ou stress dépassé.

V/ Les différentes formes de stress

A/ Selon la nature du stress :

- **Les stress cognitifs** : dus à des traumatismes psychiques : émotions violentes, peur intense, chagrins intenses à l'occasion des événements dramatiques de la vie.
- **Les stress non cognitifs** : dus à des traumatismes et blessures physiques, infections, douleurs intenses, bruits soudains ou prolongés, chaleur ou froid excessif.

B/ Selon leur durée :

- **Des stress aigus**, ponctuels.
- **Des stress intermittents** : liés à des séquences d'événements répétés.
- **Un stress permanent** : Lié à plusieurs facteurs.

Familiaux : Décès ou maladie grave d'un proche, Conflit dans la vie conjugale, Séparation, rupture, divorce.

Condition de vie : Perte d'emploi, faillite, Mutation, endettement, Précarité, misère

Maladies : Infarctus, cancer, AVC

Accidents corporels : Accident de voiture, Perte d'autonomie

Autres : Insécurité, Harcèlement

C/ Selon l'origine :

- **Le stress de base**

Ce sont des situations non familières auxquelles nous devons nous adapter.

- **Le traumatisme vicariant**

Résulte d'une surcharge émotionnelle. Se voit chez les sujets en charge de personnes en détresse (malades, blessés, cas sociaux, etc.)

- **Le burnout**

Le burnout ou épuisement professionnel découle de l'épuisement des mécanismes d'adaptation au stress subi dans le cadre du travail.

- **Le stress cumulatif**

Le stress additionne tout : les pressions professionnelles, les situations à risque, les événements de vie, etc. c'est le stress cumulatif. Il résulte :

Soit d'une exposition prolongée à un stress parfois mineur, prévisible et répétitif.

Soit de l'accumulation d'une série d'événements difficiles. Cette forme est favorisée par le manque de possibilités de récupération (manque de sommeil, de vacances, de périodes de récupération, de loisirs, etc.), des facteurs personnels de vulnérabilité (expériences antérieures très stressantes ou traumatiques non assimilées, difficultés sentimentales ou familiales, etc.).

- **Le stress traumatique**

Le stress traumatique peut apparaître lorsqu'une personne a vécu un événement traumatique, (incident critique). Un tel événement constitue une menace pour la vie, l'intégrité physique et/ou mentale d'une personne ou d'un groupe de personnes. Cette confrontation à la mort comme réelle ou possible produit une peur intense et/ou un sentiment d'impuissance et/ou d'horreur.

Les réactions surviennent dans les heures ou les jours qui suivent l'évènement traumatique.

VII-LA REACTION PSYCHOSOMATIQUE :

1. **Troubles fonctionnels** : dans lequel le médecin rencontre comme unité pathologique une expression physiologique et une expression psychologique manifestement coordonnées. Il s'agit de symptômes ou de troubles « physiques » directement liés à des émotions (un spasme, un vertige, une algie, une nausée ...).
2. **Troubles lésionnels** : il s'agit alors de véritables habitus pathologiques de longue durée, réalisant des pathologies (asthme, hypertension, etc.) qui expriment un style particulier de personnalité.

VIII- PRINCIPAUX SYNDROMES

PSYCHOSOMATIQUES :

Toutes les maladies, de la plus anodine à la plus grave, peuvent être provoquées ou aggravées par un problème psychique. Cependant, certaines affections, sont plus souvent que d'autres qualifiées de psychosomatiques.

1-appareil digestif :

- Troubles fonctionnels : troubles fonctionnels du colon anorexie, boulimie, nausées, vomissements, constipation, coliques.
- Troubles lésionnels : maladie ulcéreuse (ulcères gastroduodénaux), RCUH

2-appareil respiratoire :

- Troubles fonctionnels : dyspnée asthmatiforme, aphonie, toux, tachypnée, bégaiements
- Troubles lésionnels : asthme.

3-appareil cardiovasculaire :

- Troubles fonctionnels : douleurs précordiales, tachycardie, palpitations, HTA passagère.
- Troubles lésionnels : HTA chez les anxieux, IDM, tachycardie paroxystique.

4-appareil cutanée :

- Troubles fonctionnels : placard érythémateux, hyperesthésie, prurit, allergies, réaction vasomotrice.
- Troubles lésionnels : psoriasis, eczéma, pelade.

5-autres appareils :

- Gynécologie : douleurs, troubles du cycle, stérilité fonctionnelle.
- Endocrinologie : obésité psychosomatique, diabète.
- Céphalées et migraine.

• IV-ASPECTS THEORIQUES

On peut regrouper la théorie psychosomatique en:

- les modèles psychanalytiques ;
- les modèles non psychanalytiques

A/ Modèles psychanalytiques

se traduit par une carence des activités fantasmatiques et oniriques. Le sujet parle de chose concrètes mais rarement de ses émotions et sentiments

B/ Modèles non psychanalytiques

1/ Stress et profil comportemental de type A ou « coronarogène »

Friedman et Rosenman ont décrit en 1959 un profil comportemental dit « de type A », caractérisé par une hyperréactivité, hémodynamique et neurohumorale, au stress participant.

Les sujets de type A (ou de pattern A) aiment la compétition, la performance et s'engagent dans le travail ou les jeux pour gagner. Ils sont impatients et supportent mal l'inaction ou les obstacles à leurs objectifs.

Tendance à chercher des situations éprouvantes nécessitant un effort d'adaptation avec comme conséquence le maintien de l'organisme dans un état d'alerte répétitif, voire permanent.

2/ Patients « type C »

Les sujets du type C sont des sujets patients, acceptant les contraintes du temps, réfléchis, mais surtout soumis, conciliants, évitant activement les conflits et réprimant toute manifestation agressive. Le profil C serait avoir une valeur de facteur de risque ou de facteur pronostique dans les affections prolifératives (cancers) ou dysimmunitaires (maladies auto-immunes).

3/ Alexithymie

Concept élaboré par Sifneos (professeur en psychiatrie à Harvard) en 1973, désigne littéralement « l'absence de mot pour exprimer ses émotions » (a-lexis-thymie). Cet état se caractérise par une réelle incapacité à identifier et communiquer ses sentiments et à les différencier des sensations corporelles.

V-THERAPEUTIQUE :

- En général association de la psychothérapie et du traitement pharmacologique.
- Pour soulager des symptômes psychosomatiques, un traitement médical adapté est nécessaire, voire pour atténuer la crise : anti-inflammatoires, antiallergiques, régulateurs de transit... ces médicaments sont prescrits en fonction des symptômes observés.
- Thérapeutique brève : remplacer le symptôme par la parole (malade doit exprimer son vécu).
- cure de sommeil : poussée aigüe dangereuse (ulcère et eczéma généralisé).
- relaxation peut modifier le vécu corporel.
- Écoute psychologique (« décodage »)
- Approche psychothérapeutique : Cognitivo-comportementale, Familiale
- Approche pharmacologique : A-D (ISRS), benzodiazépines, N-L

LA PRÉVENTION

- Un mode de vie sain et équilibré : arrêt ou diminution de la consommation de nicotine, d'alcool et de caféine ; un sommeil régulier et suffisant, une alimentation saine, une activité physique suffisante.
- Des méthodes de relaxation (yoga, stretching, soins bien être : sauna, massage...) – des activités ludiques en dehors du travail (sorties, lecture, jeux) permettent de limiter le trop plein émotionnel.